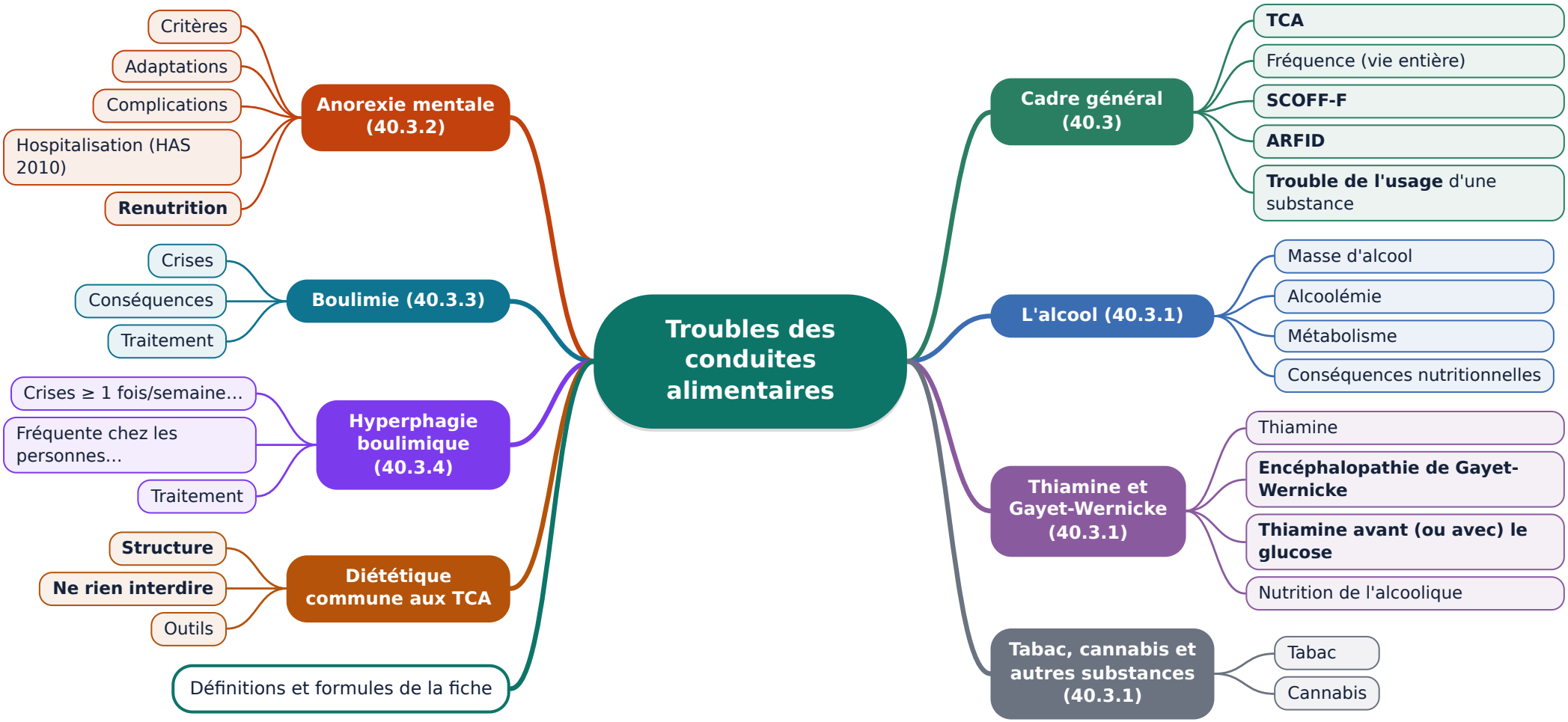
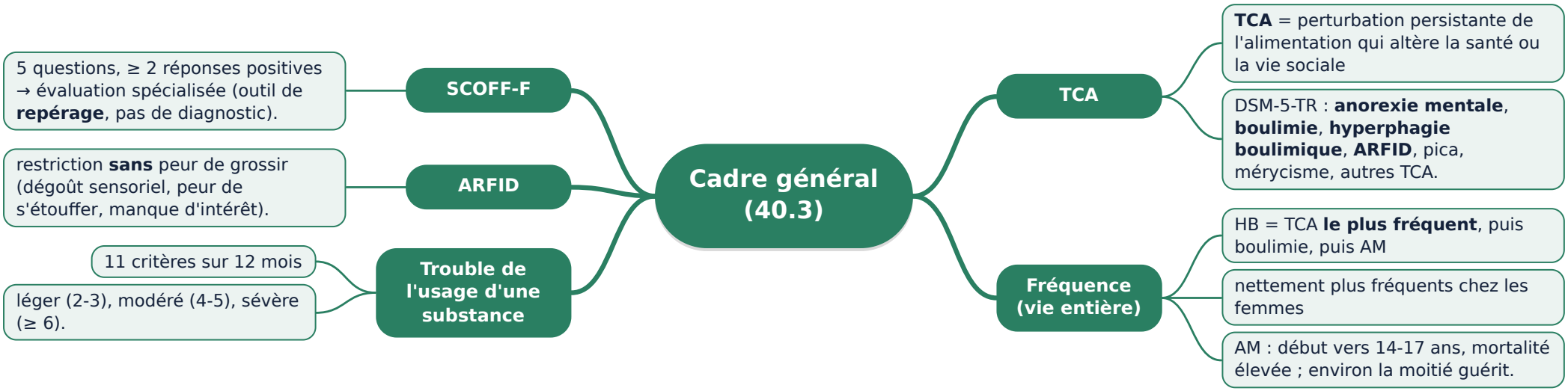
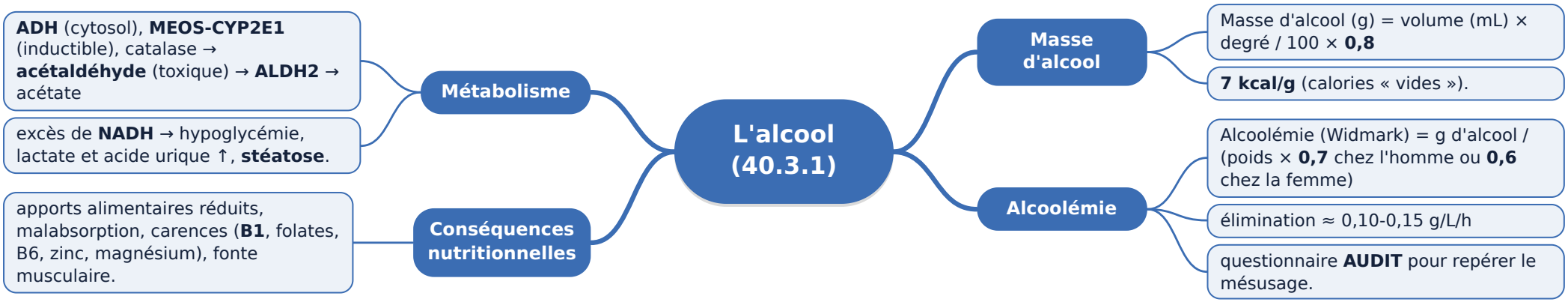
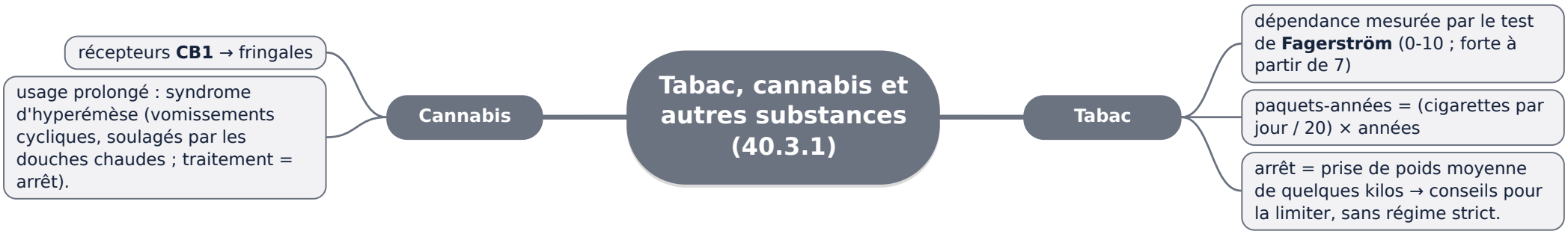
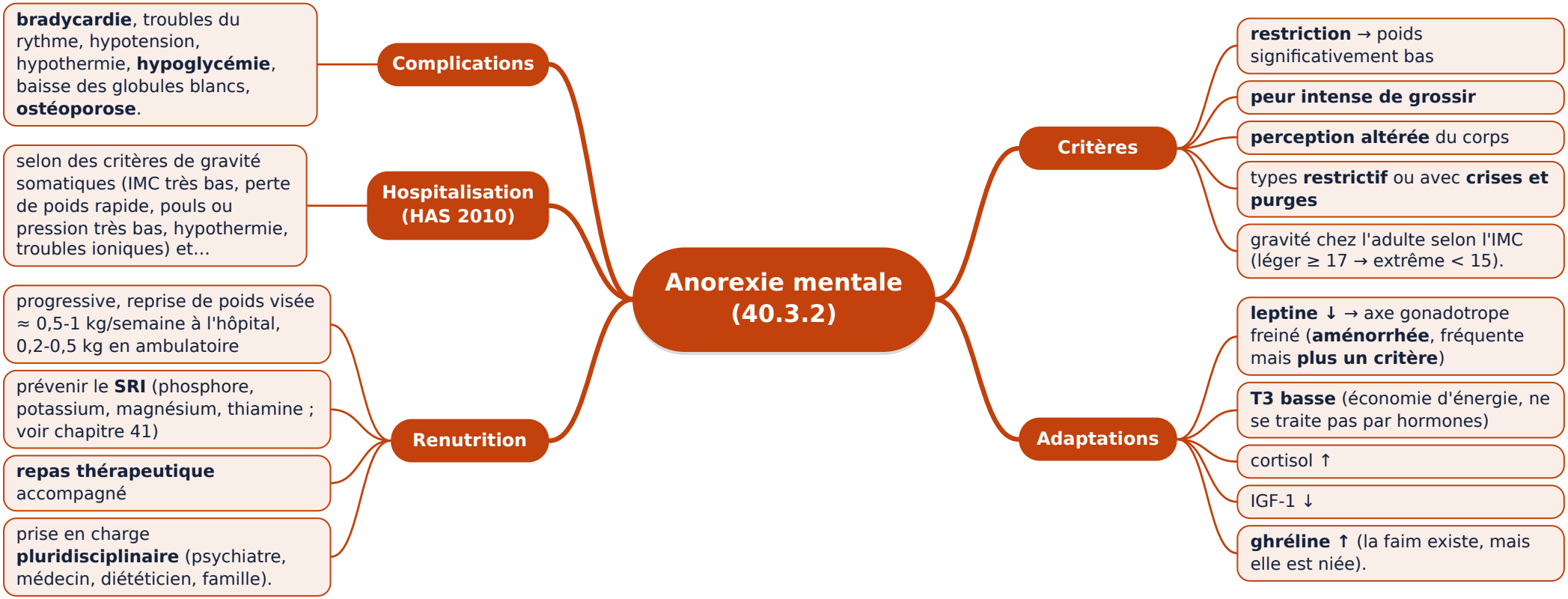

Troubles des conduites alimentaires
Anorexie mentale (40.3.2)
Critères
Adaptations
Complications
Hospitalisation (HAS 2010)
Renutrition
Boulimie (40.3.3)
Crises
Conséquences
Traitement
Hyperphagie boulimique (40.3.4)
Crises ≥ 1 fois/semaine…
Fréquente chez les personnes…
Traitement
Diététique commune aux TCA
Structure
Ne rien interdire
Outils
Définitions et formules de la fiche
Cadre général (40.3)
TCA
Fréquence (vie entière)
SCOFF-F
ARFID
Trouble de l'usage d'une substance
L'alcool (40.3.1)
Masse d'alcool
Alcoolémie
Métabolisme
Conséquences nutritionnelles
Thiamine et Gayet-Wernicke (40.3.1)
Thiamine
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke
Thiamine avant (ou avec) le glucose
Nutrition de l'alcoolique
Tabac, cannabis et autres substances (40.3.1)
Tabac
Cannabis


Cadre général (40.3)
TCA
TCA = perturbation persistante de l'alimentation qui altère la santé ou la vie sociale
DSM-5-TR : anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique, ARFID, pica, mérycisme, autres TCA.
Fréquence (vie entière)
HB = TCA le plus fréquent, puis boulimie, puis AM
nettement plus fréquents chez les femmes
AM : début vers 14-17 ans, mortalité élevée ; environ la moitié guérit.
SCOFF-F
5 questions, ≥ 2 réponses positives → évaluation spécialisée (outil de repérage, pas de diagnostic).
ARFID
restriction sans peur de grossir (dégoût sensoriel, peur de s'étouffer, manque d'intérêt).
Trouble de l'usage d'une substance
11 critères sur 12 mois
léger (2-3), modéré (4-5), sévère (≥ 6).


L'alcool (40.3.1)
Métabolisme
ADH (cytosol), MEOS-CYP2E1 (inductible), catalase → acétaldéhyde (toxique) → ALDH2 → acétate
excès de NADH → hypoglycémie, lactate et acide urique ↑, stéatose.
Conséquences nutritionnelles
apports alimentaires réduits, malabsorption, carences (B1, folates, B6, zinc, magnésium), fonte musculaire.
Masse d'alcool
Masse d'alcool (g) = volume (mL) × degré / 100 × 0,8
7 kcal/g (calories « vides »).
Alcoolémie
Alcoolémie (Widmark) = g d'alcool / (poids × 0,7 chez l'homme ou 0,6 chez la femme)
élimination ≈ 0,10-0,15 g/L/h
questionnaire AUDIT pour repérer le mésusage.


Thiamine et Gayet-Wernicke (40.3.1)
Thiamine
Thiamine (B1) → coenzyme TPP du métabolisme du glucose (pyruvate déshydrogénase, α-cétoglutarate déshydrogénase, transcétolase)
réserves faibles (quelques semaines).
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke
confusion, troubles de l'équilibre, troubles des mouvements des yeux
triade complète dans moins d'1 cas sur 5 → traiter au moindre doute
séquelle possible : syndrome de Korsakoff (amnésie).
Thiamine avant (ou avec) le glucose
le glucose sans B1 peut déclencher l'encéphalopathie
prévention systématique au sevrage.
Nutrition de l'alcoolique
repérer la dénutrition, prévenir le SRI (renutrition progressive, phosphore, potassium, magnésium), supplément vitaminique, alimentation...

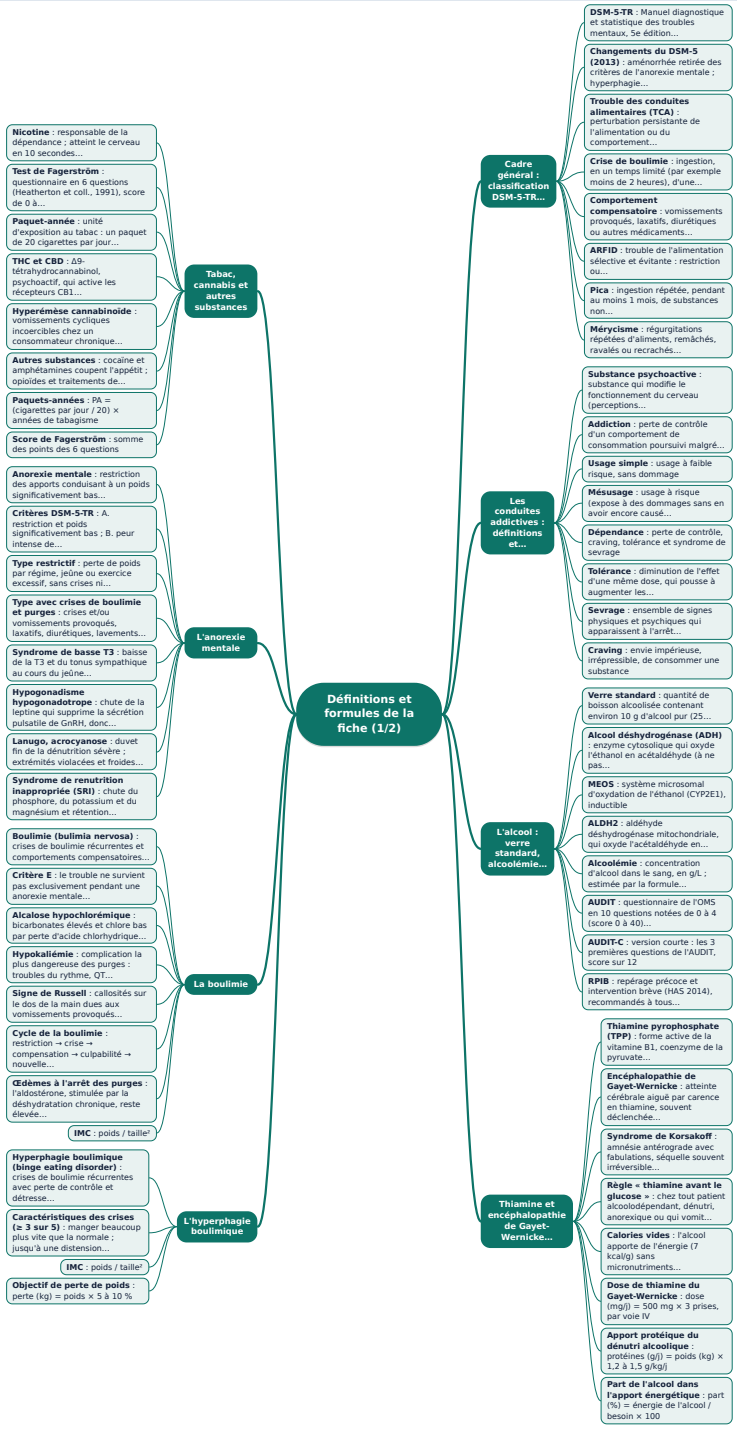

Tabac, cannabis et autres substances (40.3.1)
Cannabis
récepteurs **CB1** → fringales
usage prolongé : syndrome d'hyperémèse (vomissements cycliques, soulagés par les douches chaudes ; traitement = arrêt).
Tabac
dépendance mesurée par le test de **Fagerström** (0-10 ; forte à partir de 7)
paquets-années = (cigarettes par jour / 20) × années
arrêt = prise de poids moyenne de quelques kilos → conseils pour la limiter, sans régime strict.

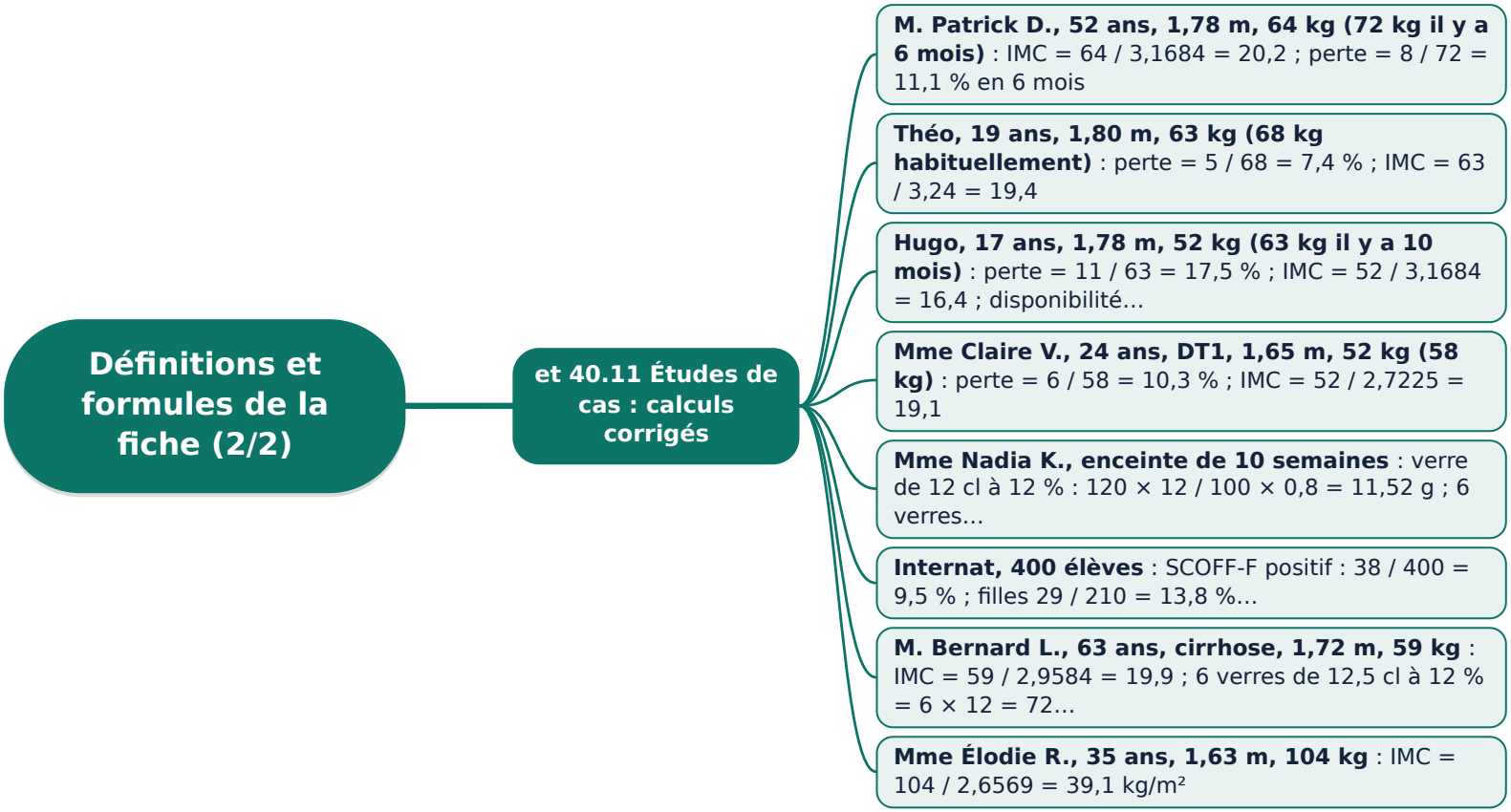

Anorexie mentale (40.3.2)
Critères
restriction → poids significativement bas
peur intense de grossir
perception altérée du corps
types restrictif ou avec crises et purges
gravité chez l'adulte selon l'IMC (léger ≥ 17 → extrême < 15).
Adaptations
leptine ↓ → axe gonadotrope freiné (aménorrhée, fréquente mais plus un critère)
T3 basse (économie d'énergie, ne se traite pas par hormones)
cortisol ↑
IGF-1 ↓
ghréline ↑ (la faim existe, mais elle est niée).
Complications
bradycardie, troubles du rythme, hypotension, hypothermie, hypoglycémie, baisse des globules blancs, ostéoporose.
Hospitalisation (HAS 2010)
selon des critères de gravité somatiques (IMC très bas, perte de poids rapide, pouls ou pression très bas, hypothermie, troubles ioniques) et...
Renutrition
progressive, reprise de poids visée ≈ 0,5-1 kg/semaine à l'hôpital, 0,2-0,5 kg en ambulatoire
prévenir le SRI (phosphore, potassium, magnésium, thiamine ; voir chapitre 41)
repas thérapeutique accompagné
prise en charge pluridisciplinaire (psychiatre, médecin, diététicien, famille).

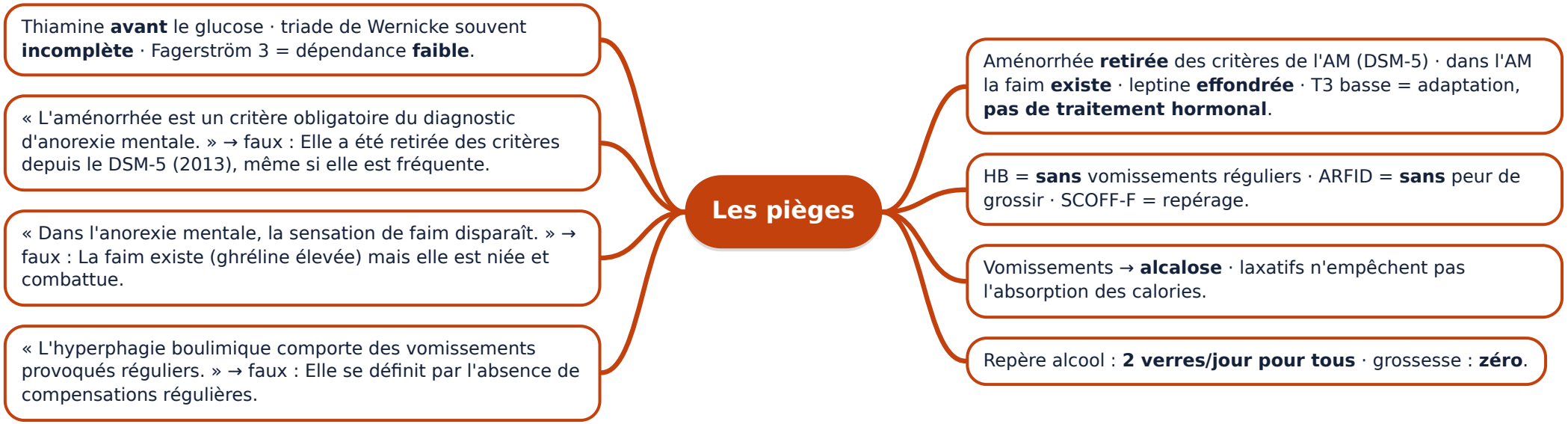

Boulimie (40.3.3)
Crises
Crises (grande quantité, **perte de contrôle**) + **comportements compensatoires** (vomissements, laxatifs, jeûne, sport excessif), au moins 1…
poids souvent **normal**
gravité selon le nombre de compensations par semaine.
Conséquences
vomissements → perte d'acide → **alcalose hypochlorémique** et **hypokaliémie** (risque cardiaque)
laxatifs → **acidose**, pertes d'eau et d'électrolytes (sans empêcher l'absorption des calories)
atteinte des dents, des glandes salivaires, de l'œsophage.
Traitement
TCC (thérapie de référence)
parfois un antidépresseur
suivi diététique.

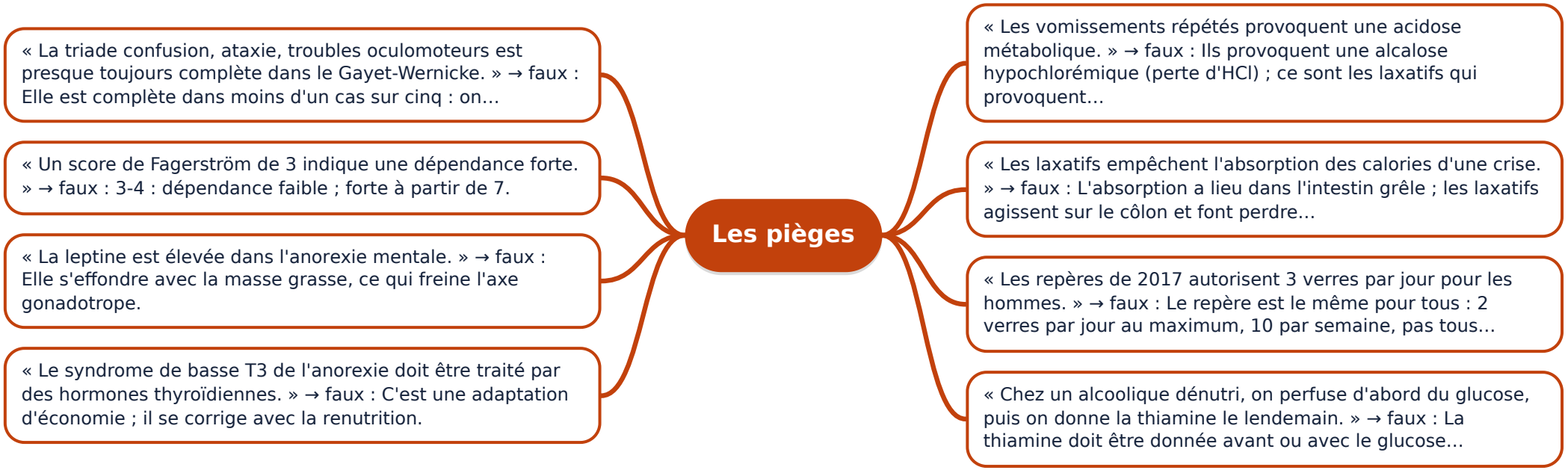

Hyperphagie boulimique (40.3.4)
Crises ≥ 1 fois/semaine…
Crises ≥ 1 fois/semaine pendant 3 mois, avec détresse et au moins 3 caractéristiques (manger vite, jusqu'à l'inconfort, sans faim, seul par honte…
sans compensation régulière.
Fréquente chez les personnes…
Fréquente chez les personnes obèses qui consultent (20-30 %).
Traitement
TCC
pas de régime restrictif (la restriction entretient les crises)
d'abord les crises, ensuite le poids (perte modérée de 5-10 %).


Diététique commune aux TCA
Outils
carnet alimentaire (boulimie, HB)
repas thérapeutique (AM)
posture bienveillante, sans jugement
travail en équipe.
Structure
3 repas + 1 à 3 collations, horaires réguliers.
Ne rien interdire
réintroduire progressivement les aliments redoutés
travailler les sensations de faim et de satiété.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Cadre général : classification DSM-5-TR…
DSM-5-TR : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition…
Changements du DSM-5 (2013) : aménorrhée retirée des critères de l'anorexie mentale ; hyperphagie…
Trouble des conduites alimentaires (TCA) : perturbation persistante de l'alimentation ou du comportement…
Crise de boulimie : ingestion, en un temps limité (par exemple moins de 2 heures), d'une…
Comportement compensatoire : vomissements provoqués, laxatifs, diurétiques ou autres médicaments…
ARFID : trouble de l'alimentation sélective et évitante : restriction ou…
Pica : ingestion répétée, pendant au moins 1 mois, de substances non…
Mérycisme : régurgitations répétées d'aliments, remâchés, ravalés ou recrachés…
Les conduites addictives : définitions et…
Substance psychoactive : substance qui modifie le fonctionnement du cerveau (perceptions…
Addiction : perte de contrôle d'un comportement de consommation poursuivi malgré…
Usage simple : usage à faible risque, sans dommage
Mésusage : usage à risque (expose à des dommages sans en avoir encore causé…
Dépendance : perte de contrôle, craving, tolérance et syndrome de sevrage
Tolérance : diminution de l'effet d'une même dose, qui pousse à augmenter les…
Sevrage : ensemble de signes physiques et psychiques qui apparaissent à l'arrêt…
Craving : envie impérieuse, irrépressible, de consommer une substance
L'alcool : verre standard, alcoolémie…
Verre standard : quantité de boisson alcoolisée contenant environ 10 g d'alcool pur (25…
Alcool déshydrogénase (ADH) : enzyme cytosolique qui oxyde l'éthanol en acétaldéhyde (à ne pas…
MEOS : système microsomal d'oxydation de l'éthanol (CYP2E1), inductible
ALDH2 : aldéhyde déshydrogénase mitochondriale, qui oxyde l'acétaldéhyde en…
Alcoolémie : concentration d'alcool dans le sang, en g/L ; estimée par la formule…
AUDIT : questionnaire de l'OMS en 10 questions notées de 0 à 4 (score 0 à 40)…
AUDIT-C : version courte : les 3 premières questions de l'AUDIT, score sur 12
RPIB : repérage précoce et intervention brève (HAS 2014), recommandés à tous…
Thiamine et encéphalopathie de Gayet-Wernicke…
Thiamine pyrophosphate (TPP) : forme active de la vitamine B1, coenzyme de la pyruvate…
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke : atteinte cérébrale aiguë par carence en thiamine, souvent déclenchée…
Syndrome de Korsakoff : amnésie antérograde avec fabulations, séquelle souvent irréversible…
Règle « thiamine avant le glucose » : chez tout patient alcoolodépendant, dénutri, anorexique ou qui vomit…
Calories vides : l'alcool apporte de l'énergie (7 kcal/g) sans micronutriments…
Dose de thiamine du Gayet-Wernicke : dose (mg/j) = 500 mg × 3 prises, par voie IV
Apport protéique du dénutri alcoolique : protéines (g/j) = poids (kg) × 1,2 à 1,5 g/kg/j
Part de l'alcool dans l'apport énergétique : part (%) = énergie de l'alcool / besoin × 100
Tabac, cannabis et autres substances
Nicotine : responsable de la dépendance ; atteint le cerveau en 10 secondes…
Test de Fagerström : questionnaire en 6 questions (Heatherton et coll., 1991), score de 0 à…
Paquet-année : unité d'exposition au tabac : un paquet de 20 cigarettes par jour…
THC et CBD : Δ9-tétrahydrocannabinol, psychoactif, qui active les récepteurs CB1…
Hyperémèse cannabinoïde : vomissements cycliques incoercibles chez un consommateur chronique…
Autres substances : cocaïne et amphétamines coupent l'appétit ; opioïdes et traitements de…
Paquets-années : PA = (cigarettes par jour / 20) × années de tabagisme
Score de Fagerström : somme des points des 6 questions
L'anorexie mentale
Anorexie mentale : restriction des apports conduisant à un poids significativement bas…
Critères DSM-5-TR : A. restriction et poids significativement bas ; B. peur intense de…
Type restrictif : perte de poids par régime, jeûne ou exercice excessif, sans crises ni…
Type avec crises de boulimie et purges : crises et/ou vomissements provoqués, laxatifs, diurétiques, lavements…
Syndrome de basse T3 : baisse de la T3 et du tonus sympathique au cours du jeûne…
Hypogonadisme hypogonadotrope : chute de la leptine qui supprime la sécrétion pulsatile de GnRH, donc…
Lanugo, acrocyanose : duvet fin de la dénutrition sévère ; extrémités violacées et froides…
Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) : chute du phosphore, du potassium et du magnésium et rétention…
La boulimie
Boulimie (bulimia nervosa) : crises de boulimie récurrentes et comportements compensatoires…
Critère E : le trouble ne survient pas exclusivement pendant une anorexie mentale…
Alcalose hypochlorémique : bicarbonates élevés et chlore bas par perte d'acide chlorhydrique…
Hypokaliémie : complication la plus dangereuse des purges : troubles du rythme, QT…
Signe de Russell : callosités sur le dos de la main dues aux vomissements provoqués…
Cycle de la boulimie : restriction → crise → compensation → culpabilité → nouvelle…
Œdèmes à l'arrêt des purges : l'aldostérone, stimulée par la déshydratation chronique, reste élevée…
IMC : poids / taille²
L'hyperphagie boulimique
Hyperphagie boulimique (binge eating disorder) : crises de boulimie récurrentes avec perte de contrôle et détresse…
Caractéristiques des crises (≥ 3 sur 5) : manger beaucoup plus vite que la normale ; jusqu'à une distension…
IMC : poids / taille²
Objectif de perte de poids : perte (kg) = poids × 5 à 10 %


Définitions et formules de la fiche (2/2)
et 40.11 Études de cas : calculs corrigés
M. Patrick D., 52 ans, 1,78 m, 64 kg (72 kg il y a 6 mois) : IMC = 64 / 3,1684 = 20,2 ; perte = 8 / 72 = 11,1 % en 6 mois
Théo, 19 ans, 1,80 m, 63 kg (68 kg habituellement) : perte = 5 / 68 = 7,4 % ; IMC = 63 / 3,24 = 19,4
Hugo, 17 ans, 1,78 m, 52 kg (63 kg il y a 10 mois) : perte = 11 / 63 = 17,5 % ; IMC = 52 / 3,1684 = 16,4 ; disponibilité…
Mme Claire V., 24 ans, DT1, 1,65 m, 52 kg (58 kg) : perte = 6 / 58 = 10,3 % ; IMC = 52 / 2,7225 = 19,1
Mme Nadia K., enceinte de 10 semaines : verre de 12 cl à 12 % : 120 × 12 / 100 × 0,8 = 11,52 g ; 6 verres…
Internat, 400 élèves : SCOFF-F positif : 38 / 400 = 9,5 % ; filles 29 / 210 = 13,8 %…
M. Bernard L., 63 ans, cirrhose, 1,72 m, 59 kg : IMC = 59 / 2,9584 = 19,9 ; 6 verres de 12,5 cl à 12 % = 6 × 12 = 72…
Mme Élodie R., 35 ans, 1,63 m, 104 kg : IMC = 104 / 2,6569 = 39,1 kg/m²


Les pièges
Thiamine **avant** le glucose · triade de Wernicke souvent **incomplète** · Fagerström 3 = dépendance **faible**.
« L'aménorrhée est un critère obligatoire du diagnostic d'anorexie mentale. » → faux : Elle a été retirée des critères depuis le DSM-5 (2013), même si elle est fréquente.
« Dans l'anorexie mentale, la sensation de faim disparaît. » → faux : La faim existe (ghréline élevée) mais elle est niée et combattue.
« L'hyperphagie boulimique comporte des vomissements provoqués réguliers. » → faux : Elle se définit par l'absence de compensations régulières.
Aménorrhée **retirée** des critères de l'AM (DSM-5) · dans l'AM la faim **existe** · leptine **effondrée** · T3 basse = adaptation, **pas de traitement hormonal**.
HB = **sans** vomissements réguliers · ARFID = **sans** peur de grossir · SCOFF-F = repérage.
Vomissements → **alcalose** · laxatifs n'empêchent pas l'absorption des calories.
Repère alcool : **2 verres/jour pour tous** · grossesse : **zéro**.


Les pièges
« La triade confusion, ataxie, troubles oculomoteurs est presque toujours complète dans le Gayet-Wernicke. » → faux : Elle est complète dans moins d'un cas sur cinq : on…
« Un score de Fagerström de 3 indique une dépendance forte. » → faux : 3-4 : dépendance faible ; forte à partir de 7.
« La leptine est élevée dans l'anorexie mentale. » → faux : Elle s'effondre avec la masse grasse, ce qui freine l'axe gonadotrope.
« Le syndrome de basse T3 de l'anorexie doit être traité par des hormones thyroïdiennes. » → faux : C'est une adaptation d'économie ; il se corrige avec la renutrition.
« Les vomissements répétés provoquent une acidose métabolique. » → faux : Ils provoquent une alcalose hypochlorémique (perte d'HCl) ; ce sont les laxatifs qui provoquent…
« Les laxatifs empêchent l'absorption des calories d'une crise. » → faux : L'absorption a lieu dans l'intestin grêle ; les laxatifs agissent sur le côlon et font perdre…
« Les repères de 2017 autorisent 3 verres par jour pour les hommes. » → faux : Le repère est le même pour tous : 2 verres par jour au maximum, 10 par semaine, pas tous…
« Chez un alcoolique dénutri, on perfuse d'abord du glucose, puis on donne la thiamine le lendemain. » → faux : La thiamine doit être donnée avant ou avec le glucose…